



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 26 — Infecções de Pele e Partes Moles: erisipela, celulite, abscesso/furúnculo, impetigo, pé diabético infectado e infecção necrotizante

Classificação de gravidade (Eron/IDSA), quando drenar, quando dar antibiótico e qual, reconhecimento da fasciíte necrotizante, diferenciais (TVP, gota, dermatite de estase), alta e transferência — cenário: PS sem cirurgião; cirúrgico → Santa Casa de Mogi Guaçu

Código	PS-ND-26	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

As infecções de pele e partes moles (IPPM) estão entre as 10 causas mais frequentes de atendimento no PS e são um dos maiores campos de **antibiótico desnecessário** (dermatite de estase, gota, TVP e eczema tratados como "celulite"; abscesso simples que só precisava de drenagem) e, no extremo oposto, de **diagnóstico tardio da infecção necrotizante** — cuja mortalidade sobe a cada hora sem desbridamento. O protocolo padroniza: quem é celulite de verdade, quem precisa de antibiótico e qual, quem vai para a Santa Casa com a faca à espera, e quem vai para casa com orientação e reavaliação em 48 h.

Fontes de ancoragem: Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the IDSA. Clin Infect Dis 2014;59:e10 [IDSA 2014]; Sartelli M, et al. 2018 WSES/SIS-E consensus conference: recommendations for the management of skin and soft-tissue infections. World J Emerg Surg 2018;13:58 [WSES 2018]; Sartelli M, et al. WSES/GAIS/SIS-E/WSIS/AAST global clinical pathways for necrotizing soft tissue infections 2022. World J Emerg Surg 2022;17:3 [WSES-NSTI 2022]; NICE NG141. Cellulitis and erysipelas: antimicrobial prescribing (2019) [NICE 2019]; Eron LJ, et al. Managing skin and soft tissue infections: expert panel recommendations. J Antimicrob Chemother 2003;52(Suppl 1):i3 [ERON 2003]; Wong CH, et al. LRINEC score. Crit Care Med 2004;32:1535; Daum RS, et al. A placebo-controlled trial of antibiotics for smaller skin abscesses. N Engl J Med 2017;376:2545; Talan DA, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus placebo for uncomplicated skin abscess. N Engl J Med 2016;374:823; **IWGDF/IDSA 2023 guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections** (Senneville É, et al. Clin Infect Dis 2023) [IWGDF 2023]; Sociedade Brasileira de Dermatologia / SBI — recomendações (edição vigente) [SBD/SBI — VERIFICAR]; Ministério da Saúde. Manual do pé diabético (2016).

Convenção de confiança: esquemas conforme IDSA 2014/NICE 2019/IWGDF 2023, para validação pela CCIH conforme prevalência local de MRSA comunitário [VERIFICAR]. **[VERIFICAR]:** cefalexina/cefazolina/oxacilina/clindamicina/SMX-TMP/pip-tazo/vancomicina em estoque, material de drenagem e anestesia local, USG/POCUS para abscesso e TVP, lactato/CPK, tempo até cirurgia na Santa Casa.

1. Queixa — como o paciente chega

"Perna vermelha, quente, inchada e dolorida" (celulite/erisipela), "caroço com pus que dói e cresceu" (abscesso/furúnculo), "ferida no pé que não fecha e ficou feia" (pé diabético), "machucado que infeccionou", "picada de inseto que inflamou", "feridas com casquinha amarela na criança" (impetigo), "febre e calafrios com a perna vermelha". A dor **desproporcional** ao aspecto, a evolução em horas, a pele "dura como madeira" e a toxemia são a queixa da infecção necrotizante — perguntar sempre.

Perguntar

- Porta de entrada: fissura interdigital (tinha pedis — a mais comum), ferida, úlcera, picada, mordedura (Protocolo 27), injeção, cirurgia, dermatite, onicomicose, edema crônico.
- Tempo de evolução (horas × dias), velocidade de progressão (marcar a borda com caneta e horário), febre/calafrios, dor intensa/desproporcional.
- Diabetes (pé, neuropatia), insuficiência venosa/linfedema, obesidade, imunossupressão (HIV, corticoide, quimioterapia), etilismo, cirrose, DRC, uso de drogas injetáveis, episódios prévios (recorrência), MRSA prévio/familiar, exposição a água (doce/salgada — *Aeromonas/Vibrio*), animais, ATB recente, alergia a penicilina (real?).
- Vacinação antitetânica (ferida).

2. Clínica — entidades, gravidade e o que não é celulite

2.1 Entidades

Entidade	Quadro	Agente habitual	Eixo do tratamento
Erisipela	Placa eritematosa bem delimitada, elevada , quente, dolorosa, de início abrupto com febre/calafrios; membros inferiores e face; linfangite/adenopatia; bolhas	<i>Streptococcus</i> β-hemolítico (grupo A, G, B)	Betalactâmico antiestreptocócico (penicilina/amoxicilina/cefalexina); repouso com elevação
Celulite	Eritema mal delimitado , edema, calor, dor; mais profunda (derme profunda/subcutâneo); pode ter febre	Estreptococo (maioria, não purulenta) ± <i>S. aureus</i> (se purulenta/abscesso/ferida)	Não purulenta: betalactâmico; purulenta: cobrir <i>S. aureus</i> (± MRSA)
Abscesso / furúnculo / carbúnculo	Nódulo flutuante, doloroso, com ponto de pus; furúnculo = foliculo; carbúnculo = múltiplos	<i>S. aureus</i> (MRSA comunitário em 20–50% em algumas séries)	Incisão e drenagem é o tratamento; antibiótico adjuvante em situações definidas (7.2)
Impetigo (crostoso/bolhoso)	Criança; crostas melicéricas ou bolhas flácidas; contagioso	<i>S. aureus</i> , estreptococo	Tópico (mupirocina) se localizado; cefalexina VO se extenso; afastar da escola 24 h
Ectima, foliculite, hidradenite, paroníquia, unha encravada, cisto sebáceo infectado	Lesões localizadas	<i>S. aureus</i> , estreptococo, anaeróbios (hidradenite)	Drenagem/cuidado local; ATB se celulite associada
Pé diabético infectado [IWGDF 2023]	Úlcera com ≥2 sinais de inflamação ou secreção purulenta; neuropatia mascara dor; osteomielite se osso exposto/sonda toca osso	Leve: cocos Gram +; moderada/grave/crônica: polimicrobiana (Gram –, anaeróbios); MRSA/Pseudomonas se ATB prévio	Classificar (leve/moderada/grave — IWGDF/IDSA), desbridar, descarregar, ATB por gravidade, avaliar isquemia (pulsos/ITB) e osteomielite; moderada/grave → Santa Casa
Infecção necrotizante (fasciíte, mionecrose, gangrena de Fournier)	Dor intensa desproporcional , edema tenso além do eritema, pele "lenhosa", anestesia cutânea , bolhas hemorrágicas, crepitação, necrose, toxemia/choque, progressão em horas; Fournier: períneo/genitália	Tipo I polimicrobiana (diabético, pós-cirúrgico, Fournier); tipo II estreptococo A (± <i>S. aureus</i>) em saudável após trauma mínimo; <i>Vibrio/Aeromonas</i> (água); <i>Clostridium</i> (gás)	Cirurgia (desbridamento) em ≤6 h + antibiótico de amplo espectro + clindamicina + suporte (Protocolo 05) → Santa Casa/UTI
Mordeduras (humana/animal)	Protocolo 27	<i>Pasteurella</i> , <i>Eikenella</i> , anaeróbios, <i>S. aureus</i>	Amoxicilina-clavulanato; profilaxia raiva/tétano

2.2 Gravidade — classificação de Eron/IDSA (decide local e via)

Classe	Descrição	Conduta
I	Sem sinais sistêmicos, sem comorbidade descompensada, tolera VO	Ambulatorial, ATB oral , reavaliar em 48 h
II	Sinais sistêmicos leves (febre) ou comorbidade (DM, obesidade, DVP, imunossupressão, etilismo) que pode complicar	Oral com reavaliação em 24–48 h; ou dose inicial IV no PS + oral; observação curta se dúvida
III	Toxemia (febre alta, taquicardia, hipotensão leve, confusão), comorbidade descompensada, extensão ampla, celulite facial/periorbitária/mão, falha do oral em 48–72 h, imunossuprimido	Internar/transferir : ATB IV
IV	Sepsis/choque, infecção necrotizante suspeita	Protocolo 05 + cirurgia imediata (Santa Casa/UTI)

2.3 O que não é celulite (30% dos "celulites" — evitar antibiótico)

Condição	Pistas
Dermatite de estase / lipodermatoesclerose	Bilateral , crônica, sem febre, hiperpigmentação, edema crônico, varizes, melhora com elevação — celulite bilateral é rara
TVP	Edema unilateral, dor em panturrilha, sem eritema em placa/calor localizado; fatores de risco → Wells/D-dímero/USG (Protocolo 19) — podem coexistir
Gota / artrite séptica	Eritema periarticular (1ª MTF, tornozelo, joelho), dor articular intensa, tofos; artrite séptica: febre + derrame → punção (Santa Casa)
Dermatite de contato / eczema / picada de inseto (reação local)	Prurido > dor, vesículas, limites da exposição, sem febre; reação a picada: eritema/edema nas primeiras 24 h sem progressão
Tromboflebite superficial	Cordão venoso palpável doloroso
Eritema migratório, eritema nodoso, herpes-zóster (fase inicial), erisipeloide, hematoma, ruptura de cisto de Baker, síndrome compartimental, calcifilaxia, carcinoma inflamatório	Contexto e evolução

3. Exame físico — o que procurar

Item	Achado / significado
Sinais vitais, sensório	Toxemia = classe III/IV; sepse (Protocolo 05)
Lesão: limites, extensão, calor, dor, flutuação, crepitação, bolhas, necrose, secreção	Marcar a borda com caneta + hora ; flutuação = abscesso (drenar); bolhas hemorrágicas/crepitação/necrose/anestesia = necrotizante
Dor desproporcional / pele lenhosa / edema além do eritema	Necrotizante até prova em contrário — não esperar exame de imagem
Porta de entrada	Interdígitos (tinha), unhas, feridas, úlceras, picadas, sítios de injeção, dentição (face)
Linfangite, adenopatia regional	Estreptococo; gravidade
Membro: pulsos, perfusão, sensibilidade, mobilidade, compartimentos	Isquemia (pé diabético — ITB), síndrome compartimental, artrite/osteomielite (dor à mobilização, osso exposto — "probe-to-bone")
Face/periorbitária	Proptose, dor à movimentação ocular, diplopia, quemose = celulite orbitária (TC + internação); região central da face → trombose de seio cavernoso
Mão	Sinais de Kanavel (tenossinovite): dedo em flexão, edema fusiforme, dor à extensão passiva, dor no trajeto do tendão → cirurgia
Períneo/genitália	Fournier: edema, crepitação, necrose, odor; toxemia desproporcional — cirurgia imediata
Estado geral	Desidratação, sinais de DM descompensado, imunossupressão, desnutrição

4. Propedêutica armada

Celulite/erisipela classe I-II não precisa de exames. Exames entram para gravidade, diferenciais e infecção necrotizante — e **nunca atrasam a cirurgia quando a clínica é de necrotizante.**

Exame	Para que serve	Quando
Hemograma, PCR	Leucocitose/PCR (gravidade; LRINEC); leucopenia = grave	Classe ≥II com febre; DM; suspeita de necrotizante
Glicemia, creatinina, Na, CPK, lactato	DM descompensado; LRA; rabdomiólise/mionecrose; sepse	Classe III/IV; necrotizante

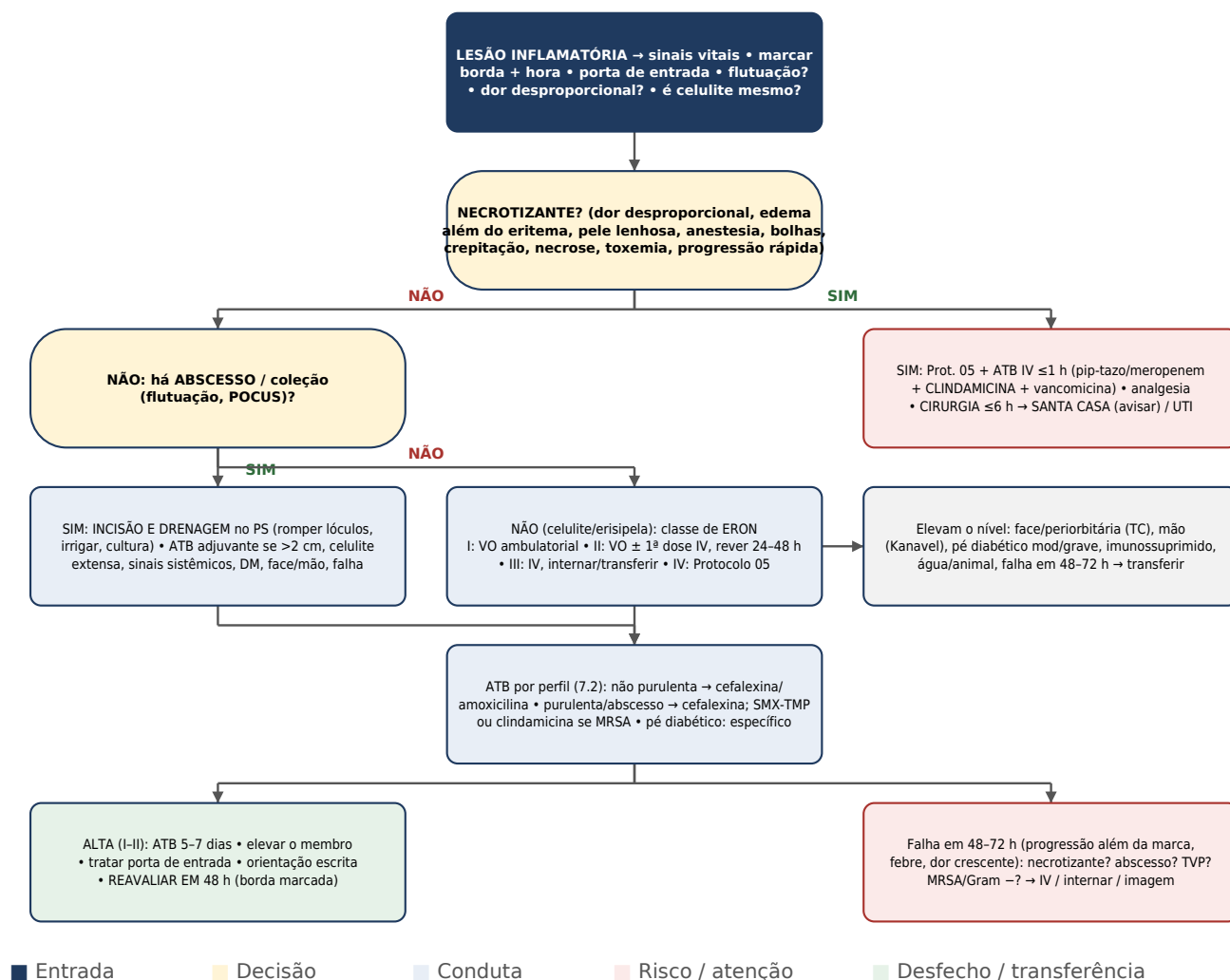
Exame	Para que serve	Quando
Hemoculturas	Positivas em <5% de celulite simples; 10-30% em grave/imunossuprimido/necrotizante	Classe III/IV, imunossuprimido, exposição a água/animal, necrotizante
Cultura de secreção/pus (Gram + cultura)	Abscesso drenado (orienta MRSA), pé diabético (tecido profundo após desbridamento — não swab superficial), necrotizante (intraoperatória)	Sempre que houver material; antes do ATB quando possível
USG/POCUS de partes moles	Abscesso (coleção) × celulite ("cobblestone"); guia a drenagem; TVP (compressão); gás (necrotizante)	Dúvida de coleção; membro edemaciado unilateral [VERIFICAR]
RX simples	Gás em partes moles (necrotizante — presença é específica, ausência não exclui), corpo estranho, osteomielite (tardia)	Necrotizante; pé diabético; ferida com corpo estranho
TC/RM	Extensão profunda, necrotizante (gás, coleções, realce fascial), celulite orbitária, osteomielite	Referência — não atrasa a cirurgia se a clínica é clara
LRINEC (PCR ≥150: 4; leucócitos 15-25: 1, >25: 2; Hb 11-13,5: 1, <11: 2; Na <135: 2; creatinina >1,6: 2; glicose >180: 1)	≥6 = risco intermediário; ≥8 alto — sensibilidade baixa (~50-70%): score baixo NÃO exclui	Apoio; a decisão é clínica (WSES 2022)
ITB / Doppler	Isquemia no pé diabético (cicatrização, amputação)	Pé diabético — referência/ambulatorial
Sorologia HIV, HbA1c	Recorrência/gravidade inexplicada; DM não diagnosticado	Selecionado

5. Fisiopatologia

A pele íntegra é a barreira; a infecção começa por uma **porta de entrada** (fissura interdigital por tinha, ferida, úlcera, picada) por onde estreptococos (produtores de estreptolisinas, hialuronidase e estreptoquinase que se espalham pelos linfáticos — erisipela e celulite não purulenta) ou *S. aureus* (coagulase e leucocidinas que formam **abscesso** localizado) invadem a derme e o subcutâneo. O **edema crônico** (insuficiência venosa, linfedema, obesidade) e a **imunossupressão** (diabetes, cirrose, HIV) reduzem a depuração linfática e a resposta local — daí a recorrência e a gravidade nesses grupos, e a importância de tratar a tinha e o edema. O abscesso é uma cavidade avascular: antibiótico não penetra — a **drenagem** é o tratamento, e o antibiótico adjuvante reduz falha e recorrência em alguns cenários (Daum 2017, Talan 2016). Na **infecção necrotizante**, bactérias (estreptococo A com superantígenos; flora mista com anaeróbios produtores de gás; *Clostridium*) proliferam ao longo da fáscia com trombose dos vasos perfurantes: a pele acima parece quase normal enquanto o subcutâneo necrosa — por isso **dor desproporcional, anestesia** (destruição de nervos) e edema além do eritema; a progressão é centimétrica por hora e o antibiótico não alcança o tecido isquêmico — **só o desbridamento controla**. A clindamicina inibe a síntese proteica e reduz a produção de toxinas do estreptococo (efeito Eagle), por isso é associada. No **pé diabético**, neuropatia (ferida indolor), isquemia (cicatrização ruim) e imunodeficiência convergem; a osteomielite ocorre por contiguidade — o teste da sonda que toca osso tem alto valor preditivo.

6. Fluxo de atendimento [IDSA 2014; WSES 2018/2022, adaptado]

Três perguntas em ordem: **é necrotizante?** (cirurgia em horas) → **tem pus para drenar?** (bisturi antes de antibiótico) → **qual a classe de Eron?** (via e local). E uma quarta antes de tudo: **é celulite mesmo?**



6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Suspeita de necrotizante → antibiótico IV + acionamento da cirurgia (Santa Casa)	≤1 h / desbridamento ≤6 h
Abscesso com flutuação → drenagem no PS	Mesmo atendimento (não "voltar amanhã com o cirurgião")
Classe III → 1ª dose IV e regulação	≤2 h
Celulite ambulatorial → reavaliação clínica	48 h (24 h se classe II/DM)
Pé diabético moderado/grave → avaliação cirúrgica/vascular	≤24 h (≤6 h se gás/necrose/abscesso profundo)

7. Tratamento — doses e vias

7.1 Drenagem de abscesso no PS

Passo	Detalhe
Indicação	Coleção flutuante ou confirmada ao POCUS; furúnculo maduro; não drenar : abscesso profundo de mão/pescoço/perineal/face central (triângulo nasolabial), próximo a vasos/nervos, mama (radiologia), perirrretal complexo → Santa Casa
Preparo	Consentimento; antissepsia (clorexidina); anestesia local (lidocaína 1–2% com ou sem vasoconstritor — evitar vasoconstritor em dedos/nariz/orelha se preferência local; bloqueio de campo); analgesia sistêmica ± sedação leve (midazolam/cetamina) em abscessos grandes
Técnica	Incisão linear no ponto de maior flutuação, seguindo linhas de tensão, ampla ($\geq 1/2$ do diâmetro); expressão; romper lóculos com pinça/dedo enluvado; irrigar com SF; coletar pus para cultura (frasco estéril); curativo absorvente; tamponamento (dreno de gaze) só em cavidades >5 cm (evidência não mostra benefício em pequenos e aumenta dor); técnica de loop (dreno com fio) é alternativa
Após	Revisão em 24–48 h; retirada de tampão em 24–48 h; banhos/compressas mornas; orientar sinais de piora; antibiótico adjuvante se critérios (7.2)
Anticoagulado / imunossuprimido / DM	Drenar do mesmo modo com hemostasia cuidadosa; limiar mais baixo para ATB e reavaliação

7.2 Antibióticos [IDSA 2014; NICE 2019; WSES 2018; IWGDF 2023] [VERIFICAR CCIH — prevalência de MRSA comunitário]

Situação	Esquema (adulto, função renal normal)	Duração / observações
Erisipela / celulite não purulenta, classe I-II	Cefalexina 500 mg-1 g VO 6/6 h ou amoxicilina 500 mg-1 g 8/8 h ou penicilina V 500 mg 6/6 h; alergia: clindamicina 300-450 mg 8/8 h; 1ª dose IV opcional: cefazolina 1-2 g IV	5 dias (estender a 7-10 se lenta resposta — IDSA/NICE); criança: cefalexina 50 mg/kg/dia 6/6 h
Celulite purulenta / abscesso com indicação de ATB (≥2 cm, celulite extensa, sinais sistêmicos, DM/imunossupressão, face/mão/genitália, falha da drenagem, múltiplos)	Cefalexina (se MRSA improvável) ou SMX-TMP 800/160 mg 12/12 h (Talan 2016) ou clindamicina 300-450 mg 8/8 h (Daum 2017) — cobrem MRSA comunitário; doxiciclina 100 mg 12/12 h alternativa	5-7 dias após drenagem; cultura orienta
Classe III (internado)	Cefazolina 1-2 g IV 8/8 h ou oxacilina 2 g IV 4/4 h; se MRSA suspeito/colonizado/purulenta grave: vancomicina 15-20 mg/kg 12/12 h (ataque 25 mg/kg) ou clindamicina 600-900 mg IV 8/8 h (se sensível); alergia grave: vancomicina/clindamicina	IV até melhora clínica (48-72 h) → VO; total 7-10 dias
Infecção necrotizante (classe IV)	Piperacilina-tazobactam 4,5 g 6/6 h (ou meropenem 1 g 8/8 h) + clindamicina 900 mg IV 8/8 h (antitoxina) + vancomicina ; estreptococo A confirmado: penicilina G 4 milhões UI 4/4 h + clindamicina; <i>Vibrio</i> : doxiciclina + ceftriaxona	Cirurgia é o tratamento; ATB até ≥48-72 h após o último desbridamento com estabilidade; imunoglobulina IV em choque tóxico estreptocócico (referência)
Pé diabético infectado [IWGDF 2023]	Leve (superficial, eritema ≤2 cm, sem ATB recente): cefalexina 500 mg 6/6 h ou amoxicilina-clavulanato 875/125 12/12 h, 1-2 semanas. Moderada (>2 cm, profunda, abscesso, osteomielite sem sinais sistêmicos): amoxicilina-clavulanato IV/VO ou ceftriaxona 2 g + metronidazol 500 mg 8/8 h; + cobertura MRSA se fator de risco; Grave (sinais sistêmicos): pip-tazo 4,5 g 6/6 h ± vancomicina (Protocolo 05). Osteomielite: 3-6 semanas (ou ≤1 semana após ressecção completa)	Desbridamento do tecido necrótico e descarga (offloading) são obrigatórios ; avaliar isquemia (pulsos, ITB); RX; cultura de tecido profundo; moderada/grave → Santa Casa (cirurgia/vascular); controle glicêmico; sem ATB em úlcera sem sinais de infecção
Impetigo	Localizado: mupirocina 2% tópica 8/8 h por 5 dias; extenso/bolhoso: cefalexina 50 mg/kg/dia (criança) / 500 mg 6/6 h por 7 dias	Higiene, unhas curtas, afastar da escola 24 h; investigar escabiose associada
Exposição a água doce (<i>Aeromonas</i>) / salgada (<i>Vibrio</i>)	Ciprofloxacino 500-750 mg 12/12 h ou SMX-TMP + cobertura de estreptococo; <i>Vibrio</i> : doxiciclina 100 mg 12/12 h + ceftriaxona 2 g/dia	Cirrótico com <i>Vibrio</i> = alta letalidade → internar
Celulite periorbitária x orbitária	Pré-septal leve: amoxicilina-clavulanato VO; orbitária (proptose, dor ocular, diplopia): ceftriaxona 2 g 12/12 h + vancomicina + TC → oftalmologia/otorrino (referência)	Criança <1 ano: internar
Mão (tenossinovite, espaço profundo)	Ampicilina-sulbactam 3 g 6/6 h ou cefazolina + cirurgia	Kanavel → Santa Casa em horas

7.3 Medidas gerais e de recorrência

- **Elevação do membro** (acima do coração, várias vezes ao dia) — reduz edema e dor e acelera a resolução; repouso relativo; analgesia (dipirona/paracetamol; AINE curto se sem contraindicação — não mascara necrotizante quando o exame é seriado).
- Tratar a **porta de entrada**: tinha pedis (terbinafina/cetoconazol tópico 2–4 semanas), onicomicose, fissuras (hidratação), eczema, úlcera venosa (compressão após a fase aguda), unha encravada.
- Compressão elástica após a fase aguda em insuficiência venosa/linfedema; controle de peso; cuidado com a pele.
- **Recorrência (≥2/ano)**: penicilina benzatina 1,2 milhão UI IM a cada 3–4 semanas ou penicilina V 250–500 mg 12/12 h por 6–12 meses (PATCH I/II — reduz recorrência enquanto em uso); encaminhar à APS/dermatologia/vascular.
- Profilaxia antitetânica conforme ferida e vacinação (Protocolo 27/34); glicemia no diabético; hidratação.
- Descolonização de MRSA (mupirocina nasal + clorexidina) em recorrência de abscessos — ambulatorial.

8. Como conduzir o caso — transferência, permanência e indicadores

8.1 Quem transferir / internar

Situação	Urgência	Destino
Suspeita de infecção necrotizante / Fournier / gangrena gasosa; sepse (classe IV)	Imediata (ATB e volume em curso; avisar a cirurgia antes de sair)	Santa Casa (cirurgia) + UTI (Tabajara Ramos se sem UTI cirúrgica) [VERIFICAR fluxo de UTI cirúrgica]
Abscesso profundo (mão, pescoço, perianal complexo, mama, face central), tenossinovite, artrite séptica, celulite orbitária	Mesmo dia (horas)	Santa Casa (cirurgia/ortopedia/oftalmo)
Pé diabético moderado/grave, osteomielite, isquemia crítica	≤24 h (≤6 h se abscesso/gás/necrose)	Santa Casa (cirurgia/vascular)
Classe III (toxemia, comorbidade descompensada, extensão ampla, falha do oral) sem leito de observação IV 24–48 h no PS	Mesmo dia	Enfermaria — Tabajara Ramos
Classe I–II	Alta com reavaliação em 48 h	APS/UBS

8.2 Transporte e documentação

- Necrotizante: como sepse (Protocolo 05); membro elevado; fotografia com escala e hora; borda marcada.
- Relatório: lesão (local, dimensões, borda marcada e horário, sinais de necrotizante), classe de Eron, sinais vitais, exames (PCR, CPK, lactato, LRINEC), culturas colhidas, **antibiótico com dose/hora**, drenagem realizada, comorbidades (DM, imunossupressão), alergia, vacinação antitetânica.
- Regulação: CROSS-SP / SAMU 192.

8.3 Alta — pacote

- Receita com duração explícita (5 dias na celulite não complicada); orientação escrita: elevar o membro, analgesia, sinais de piora (progressão além da marca, febre, dor crescente, bolhas, escurecimento) → retorno imediato; **reavaliação agendada em 48 h** (UBS ou PS).
- Tratamento da porta de entrada e das condições de base; encaminhar pé diabético à APS/equipe de pé; recorrência → profilaxia.
- Registrar a classe, o diagnóstico diferencial considerado e a marca da borda no prontuário.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% com classe de Eron, borda marcada com hora e porta de entrada documentadas	≥90%
% de abscessos flutuantes drenados no PS no mesmo atendimento (não cirúrgicos profundos)	≥90%
% de suspeita de necrotizante com ATB em ≤1 h e cirurgia acionada em ≤1 h	100%
% de celulite não purulenta tratada com betalactâmico de espectro estreito por 5-7 dias (não quinolona/amplo espectro)	≥85%
% de altas com reavaliação agendada em 48 h	≥90%
ATB em dermatite de estase bilateral/gota/picada sem celulite; abscesso tratado só com ATB sem drenagem (eventos)	Registrar; reduzir
% de pé diabético com desbridamento/offloading e avaliação vascular documentados	≥80%
Retorno em 72 h por falha; diagnóstico tardio de necrotizante (revisão de caso)	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Duração da celulite	IDSA 2014: 5 dias se melhora; NICE 2019: 5-7 dias; prática: 7-10. Adotados 5 dias com extensão se lenta
ATB após drenagem de abscesso	IDSA 2014: só com critérios; Daum 2017/Talan 2016: benefício modesto mesmo em pequenos (menos falha/recorrência). Adotado: critérios ampliados (≥2 cm etc.) com decisão compartilhada
Tamponamento do abscesso	Evidência não mostra benefício em <5 cm; loop drainage alternativa. Adotado só em grandes
LRINEC	Sensibilidade baixa (WSES 2022); nunca para excluir. Adotado só como apoio
Cobertura empírica de MRSA	Depende da prevalência local (Brasil: variável, 10-50% em abscessos); adotada só em purulenta/abscesso com indicação de ATB ou fator de risco [VERIFICAR CCIH]
Profilaxia de recorrência	PATCH: penicilina reduz recorrência enquanto em uso; IDSA/NICE recomendam em ≥3-4 episódios/ano. Adotado ≥2/ano com decisão compartilhada
Pé diabético — classificação	IWGDF/IDSA 2023 substitui PEDIS/Wagner; MS 2016 usa Wagner. Adotada IWGDF
USG/POCUS, material de drenagem, vancomicina, clindamicina IV, pip-tazo	Disponibilidade [VERIFICAR]
UTI cirúrgica para necrotizante	Santa Casa (cirurgia) × Tabajara Ramos (UTI) — fluxo a pactuar [VERIFICAR]

10. Referências

- Stevens DL, Bisno AL, Chambers HF, et al. Practice guidelines for the diagnosis and management of skin and soft tissue infections: 2014 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 2014;59(2):e10-e52.
- Sartelli M, Guirao X, Hardcastle TC, et al. 2018 WSES/SIS-E consensus conference: recommendations for the management of skin and soft-tissue infections. World J Emerg Surg 2018;13:58. Sartelli M, Coccolini F, Kluger Y, et al. WSES/GAIS/WSIS/SIS-E/AAST global clinical pathways for patients with necrotizing soft tissue infections. World J Emerg Surg 2022;17:3.
- National Institute for Health and Care Excellence. Cellulitis and erysipelas: antimicrobial prescribing (NG141), 2019. Eron LJ, Lipsky BA, Low DE, et al. Managing skin and soft tissue infections: expert panel recommendations on key decision points. J Antimicrob Chemother 2003;52(Suppl 1):i3-i17.
- Wong CH, Khin LW, Heng KS, et al. The LRINEC score. Crit Care Med 2004;32(7):1535-1541. Daum RS, Miller LG, Immergluck L, et al. A placebo-controlled trial of antibiotics for smaller skin abscesses. N Engl J Med 2017;376(26):2545-2555. Talan DA, Mower WR, Krishnadasan A, et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole versus placebo for uncomplicated skin abscess. N Engl J Med 2016;374(9):823-832. Thomas KS, et al. Penicillin to prevent recurrent leg cellulitis (PATCH I). N Engl J Med 2013;368:1695-1703.
- Senneville É, Albalawi Z, van Asten SA, et al. IWGDF/IDSA guidelines on the diagnosis and treatment of diabetes-related foot infections (IWGDF/IDSA 2023). Clin Infect Dis 2023 (ciad527). Brasil. Ministério da Saúde. Manual do pé diabético: estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica. Brasília, 2016.
- Sociedade Brasileira de Dermatologia; Sociedade Brasileira de Infectologia — recomendações para infecções de pele e partes moles (edição vigente) [VERIFICAR].
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de infecções de pele e partes moles (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração